

TÚNEL DO CARPO — AGUDO É EMERGÊNCIA CIRÚRGICA

TÚNEL DO CARPO — CRÔNICA vs AGUDA

Aspecto	Crônica (comum)	Aguda (rara, emergência)
Instalação	Meses-anos, progressiva	Horas, dor intensa e crescente
Causa	Compressão repetitiva, idiopática, gravidez, hipotireoidismo, DM	Fratura/luxação do punho, hematoma, infecção, injeção, queimadura
Dor	Parestesia noturna, melhora ao sacudir a mão	Dor intensa, desproporcional, contínua
Déficit	Hipoestesia dos 3,5 dedos radiais; atrofia tenar tardia	Déficit sensitivo-motor PROGRESSIVO e rápido
Conduta	Conservador (órtese, infiltração) ou cirurgia eletiva	Descompressão cirúrgica de URGÊNCIA
Risco	Lesão lenta, geralmente reversível	Lesão isquêmica irreversível do nervo mediano

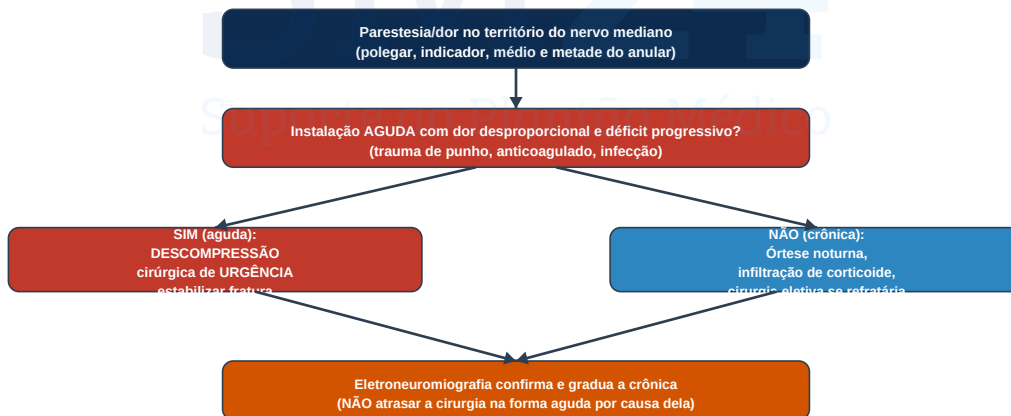
A FORMA AGUDA É UMA EMERGÊNCIA DA MÃO

DOR DESPROPORCIONAL + DÉFICIT PROGRESSIVO = DESCOMPRIMIR JÁ

- A síndrome do túnel do carpo AGUDA é uma compressão de instalação rápida com risco de lesão isquêmica permanente do nervo mediano
- Causas: fratura/luxação do punho (ex.: fratura de rádio distal), hematoma (anticoagulado), infecção, injeção, queimadura, esforço extremo
- Quadro: dor intensa e desproporcional + parestesia/déficit motor PROGRESSIVOS no território do mediano
- Conduta: descompressão cirúrgica de urgência (liberação do túnel do carpo) — não aguardar eletrofisiologia
- Em fraturas, reduzir/estabilizar e reavaliar o nervo; se piora, descomprimir
- Diferenciar de síndrome compartimental do antebraço/mão (também emergência)

ABORDAGEM

TÚNEL DO CARPO — AGUDO ou CRÔNICO?



EXAME FÍSICO E TESTES

Teste/Sinal	Como fazer / significado
Território do mediano	Polegar, indicador, médio e metade radial do anular (poupa o quinto dedo)
Sinal de Tinel	Percussão sobre o túnel do carpo reproduz a parestesia
Teste de Phalen	Flexão dos punhos por 60s reproduz os sintomas
Atrofia tenar	Sinal tardio de compressão crônica (fraqueza de abdução do polegar)
Pesquisar a causa aguda	Trauma do punho, uso de anticoagulante, sinais de infecção, injeção recente
Sinais de gravidade	Déficit motor progressivo, dor desproporcional = forma aguda

TRATAMENTO

Forma Crônica

- Órtese noturna em posição neutra do punho
- Modificar atividades repetitivas / ergonomia
- Infiltração de corticoide no túnel do carpo
- Tratar a causa de base (hipotireoidismo, DM, gravidez tende a resolver pós-parto)
- Cirurgia eletiva (liberação) se refratária ou com déficit motor/atrofia
- Eletroneuromiografia confirma e gradua

Forma Aguda

- Reconhecer dor desproporcional + déficit progressivo = emergência
- Descompressão cirúrgica de urgência do túnel do carpo
- Estabilizar fratura/luxação associada do punho
- Drenar hematoma; reverter anticoagulação se for a causa
- Não aguardar eletroneuromiografia para operar
- Monitorar evolução neurológica

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Identificar o território do nervo mediano e testar Tinel/Phalen
- ☐ Distinguir a forma crônica (progressiva, comum) da AGUDA (dor desproporcional + déficit rápido)
- ☐ Forma aguda (trauma de punho, anticoagulado, infecção): emergência cirúrgica
- ☐ Descompressão de urgência na forma aguda; não atrasar por eletroneuromiografia
- ☐ Forma crônica: órtese, infiltração e cirurgia eletiva se refratária
- ☐ Tratar a causa de base e estabilizar fraturas associadas

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com fratura de rádio distal evolui em horas com dor intensa e desproporcional e parestesia progressiva no polegar, indicador e médio. Qual a conduta?

- A) Órtese noturna e reavaliação ambulatorial
- B) Síndrome do túnel do carpo aguda — descompressão cirúrgica de urgência
- C) Apenas analgésico e gelo
- D) Infiltração de corticoide no consultório
- E) Eletroencefalografia antes de qualquer conduta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual território sensitivo é afetado na síndrome do túnel do carpo?

- A) Quinto dedo e metade do anular
- B) Polegar, indicador, médio e metade radial do anular (nervo mediano)
- C) Dorso da mão
- D) Todo o membro superior
- E) Apenas o polegar

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual o tratamento inicial da síndrome do túnel do carpo CRÔNICA leve a moderada?

- A) Cirurgia de urgência
- B) Órtese noturna e/ou infiltração de corticoide, com cirurgia eletiva se refratária
- C) Amputação
- D) Antibiótico
- E) Imobilização gessada por 3 meses

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

O que diferencia a forma AGUDA da síndrome do túnel do carpo e exige conduta de emergência?

- A) Parestesia noturna que melhora ao sacudir a mão
- B) Dor desproporcional com déficit sensitivo-motor rapidamente progressivo
- C) Atrofia tenar de longa data
- D) Sintomas apenas durante atividades repetitivas
- E) Melhora espontânea em semanas

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Na forma aguda da síndrome do túnel do carpo, qual conduta é INCORRETA?

- A) Realizar a descompressão cirúrgica de urgência
- B) Aguardar a eletroencefalografia antes de operar, mesmo com déficit progressivo
- C) Estabilizar a fratura associada do punho
- D) Reverter a anticoagulação se o hematoma for a causa
- E) Monitorar a evolução neurológica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Dor intensa e desproporcional + parestesia progressiva no território do mediano após fratura de rádio distal caracteriza a síndrome do túnel do carpo AGUDA, uma emergência: requer descompressão cirúrgica de urgência para evitar lesão isquêmica permanente do nervo.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O nervo mediano inerva o polegar, indicador, médio e a metade radial do anular (poupa o quinto dedo e a metade ulnar do anular, que são do nervo ulnar). Esse é o território de parestesia da síndrome do túnel do carpo.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na forma crônica leve a moderada, o tratamento inicial é conservador: órtese noturna em posição neutra e/ou infiltração de corticoide no túnel do carpo, reservando a cirurgia eletiva (liberação) para casos refratários ou com déficit motor/atrofia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A forma aguda se caracteriza por dor desproporcional e déficit sensitivo-motor rapidamente progressivo (geralmente após trauma de punho, em anticoagulado ou infecção), exigindo descompressão de urgência — diferente da crônica, de instalação lenta.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

É INCORRETO aguardar a eletroneuromiografia para operar a forma aguda com déficit progressivo — isso atrasaria a descompressão e poderia causar lesão irreversível do nervo. A cirurgia de urgência não deve ser postergada por exames eletrofisiológicos.

SM24
Suporte ao Plantão Médico